ICS 11.020
CCS C 05

中华人民共和国国家标准

GB/T 21709.2—2021
代替 GB/T 21709.2—2008

针灸技术操作规范　第2部分:头针

Standardized manipulations of acupuncture and moxibustion—Part 2:Scalp acupuncture

2021-11-26 发布　　2021-11-26 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

目　　次

前言 …… Ⅲ
引言 …… Ⅴ
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　操作步骤与要求 …… 1
4.1　施术前准备 …… 1
4.2　施术方法 …… 2
4.3　施术异常情况的处理 …… 3
5　注意事项 …… 3
6　禁忌 …… 3
附录A（资料性）　头针穴线的定位和主治 …… 4
附录B（规范性）　头针异常情况的处理和预防 …… 9

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件是 GB/T 21709《针灸技术操作规范》的第 2 部分。GB/T 21709 已经发布了以下部分:

——第 1 部分:艾灸;
——第 2 部分:头针;
——第 3 部分:耳针;
——第 4 部分:三棱针;
——第 5 部分:拔罐;
——第 6 部分:穴位注射;
——第 7 部分:皮肤针;
——第 8 部分:皮内针;
——第 9 部分:穴位贴敷;
——第 10 部分:穴位埋线;
——第 11 部分:电针;
——第 12 部分:火针;
——第 13 部分:芒针;
——第 14 部分:鍉针;
——第 15 部分:眼针;
——第 16 部分:腹针;
——第 17 部分:鼻针;
——第 18 部分:口唇针;
——第 19 部分:腕踝针;
——第 20 部分:毫针基本刺法;
——第 21 部分:毫针基本手法;
——第 22 部分:刮痧。

本文件代替 GB/T 21709.2—2008《针灸技术操作规范　第 2 部分:头针》,与 GB/T 21709.2—2008 相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:

——在“术语和定义”中增加了斜刺法(见 3.3);
——更改了体位选择的表述(见 4.1.3,2008 年版的 3.1.3);
——更改了部位消毒的表述(见 4.1.5.2,2008 年版的 3.1.5.2);
——更改了进针角度的表述(见 4.2.1,2008 年版的 3.2.1);
——更改了捻转的表述(见 4.2.3.1,2008 年版的 3.2.4.1);
——更改了提插的表述(见 4.2.3.2,2008 年版的 3.2.4.2);
——增加了关于留针的相关表述(见 4.2.5);
——更改了头发较密部位注意事项的表述(见 5.3,2008 年版的 4.3);
——更改了禁忌的表述(见 6.3,2008 年版的 5.3);
——更改了附录 A 中的头针穴名(见图 A.3,2008 年版的图 A.3)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由国家中医药管理局提出。

本文件由全国针灸标准化技术委员会(SAC/TC 475)归口。

本文件起草单位:长春中医药大学、北京中医药大学、甘肃中医药大学、辽宁中医药大学、山东中医药大学。

本文件主要起草人:王富春、刘清国、严兴科、李铁、马铁明、高树中、王洪峰、高颖、蒋海琳。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——2008 年首次发布为 GB/T 21709.2—2008;

——本次为第一次修订。

引　言

针灸技术操作规范是对各种针灸疗法操作程序、步骤、方法等方面所做的统一技术操作规定。在针灸技术操作规范方面，我国已经制定了系列标准 GB/T 21709。GB/T 21709《针灸技术操作规范》旨在确立普遍适用于针灸临床、教育、科研等方面关于针灸技术操作的工作准则，拟由 22 部分组成。

——第 1 部分：艾灸。目的主要在于规范艾灸疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应艾灸实践发展新变化与新需求。

——第 2 部分：头针。目的主要在于规范头针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应头针实践发展新变化与新需求。

——第 3 部分：耳针。目的主要在于规范耳针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应耳针实践发展新变化与新需求。

——第 4 部分：三棱针。目的主要在于规范三棱针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应三棱针实践发展新变化与新需求。

——第 5 部分：拔罐。目的主要在于规范拔罐疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应拔罐实践发展新变化与新需求。

——第 6 部分：穴位注射。目的主要在于规范穴位注射疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位注射实践发展新变化与新需求。

——第 7 部分：皮肤针。目的主要在于规范皮肤针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应皮肤针实践发展新变化与新需求。

——第 8 部分：皮内针。目的主要在于规范皮内针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应皮内针实践发展新变化与新需求。

——第 9 部分：穴位贴敷。目的主要在于规范穴位贴敷疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位贴敷实践发展新变化与新需求。

——第 10 部分：穴位埋线。目的主要在于规范穴位埋线疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应穴位埋线实践发展新变化与新需求。

——第 11 部分：电针。目的主要在于规范电针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应电针实践发展新变化与新需求。

——第 12 部分：火针。目的主要在于规范火针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应火针实践发展新变化与新需求。

——第 13 部分：芒针。目的主要在于规范芒针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应芒针实践发展新变化与新需求。

——第 14 部分：鍉针。目的主要在于规范鍉针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应鍉针实践发展新变化与新需求。

——第 15 部分：眼针。目的主要在于规范眼针疗法的相关概念、操作步骤与要求、适应症、注意事项、禁忌等，以适应眼针实践发展新变化与新需求。

——第 16 部分：腹针。目的主要在于规范腹针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应腹针实践发展新变化与新需求。

——第 17 部分：鼻针。目的主要在于规范鼻针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应鼻针实践发展新变化与新需求。

——第 18 部分：口唇针。目的主要在于规范口唇针疗法的相关概念、操作步骤与要求、疗程与适应

症、注意事项、禁忌等，以适应口唇针实践发展新变化与新需求。

——第 19 部分：腕踝针。目的主要在于规范腕踝针疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应腕踝针实践发展新变化与新需求。

——第 20 部分：毫针基本刺法。目的主要在于规范毫针基本刺法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应毫针基本刺法实践发展新变化与新需求。

——第 21 部分：毫针基本手法。目的主要在于规范毫针针刺手法的相关概念、施术方法、注意事项、禁忌等，以适应毫针基本手法实践发展新变化与新需求。

——第 22 部分：刮痧。目的主要在于规范刮痧疗法的相关概念、操作步骤与要求、注意事项、禁忌等，以适应刮痧实践发展新变化与新需求。

针灸技术操作规范　第2部分:头针

1　范围

本文件规定了头针的操作步骤与要求、操作方法、注意事项与禁忌。

本文件适用于头针技术操作。

2　规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

3　术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

头针　scalp acupuncture

头皮针

在头皮特定部位针刺的治疗方法。

3.2

平刺法　transverse needling

沿皮刺

横刺法

指进针时,针体和头皮穴线皮肤呈15°左右刺入的刺法。

3.3

斜刺法　oblique needling

指进针时,针体和头皮穴线皮肤呈30°左右刺入的刺法。

4　操作步骤与要求

4.1　施术前准备

4.1.1　针具选择

应根据病情和操作部位选择不同型号的毫针。应选择针身光滑、无锈蚀和折痕,针柄牢固,针尖锐利、无倒钩的针具。

4.1.2　穴线选择

应根据疾病选用不同头针穴线治疗,头针穴线的定位和主治见附录A。

4.1.3　体位选择

应选择坐位或卧位,既使患者感觉舒适、又便于医者操作的治疗体位为宜。

4.1.4 环境要求

应注意环境清洁卫生，避免污染。

4.1.5 消毒

4.1.5.1 针具消毒

应选择高压消毒法。宜选择一次性毫针。

4.1.5.2 部位消毒

应选用75%医用乙醇或70%异丙醇溶液的棉球或棉签在施术部位由中心向外环行擦拭。

4.1.5.3 术者消毒

医者双手应用肥皂水清洗干净，再用75 %医用乙醇消毒棉球擦拭。

4.2 施术方法

4.2.1 进针角度

根据患者病情、体位及所要操作的穴线，可采取斜刺法或平刺法进针。

4.2.2 快速进针

将针迅速刺入皮下，当针尖达到帽状腱膜下层时，指下感到阻力减小，然后使针与头皮平行，根据不同穴线刺入不同深度。

4.2.3 进针深度

进针深度宜根据患者具体情况和处方要求决定。一般情况下，针刺入帽状腱膜下层后，使针体平卧，进针3 cm左右为宜。

4.2.4 行针

4.2.4.1 捻转

在针体进入帽状腱膜下层后，术者肩、肘、腕关节和拇指固定不动，以保持毫针相对固定。食指第一、二节呈半屈曲状，用食指第一节的桡侧面与拇指第一节的掌侧面持住针柄，然后食指掌指关节做伸屈运动，使针体快速旋转，要求捻转频率在120次/min～180次/min，持续1 min～2 min。

4.2.4.2 提插

手持毫针沿皮刺入帽状腱膜下层，将针向内推进3 cm左右，保持针体平卧，用拇、食指紧捏针柄，进行提插，指力应均匀一致，如此反复操作，持续2 min～3 min，提插的幅度不宜过大，频率视患者的病情而定。

4.2.4.3 弹拨针柄

在头针留针期间，可用手指弹拨针柄，用力宜适度，速度不宜过快。一般可用于不宜过强刺激之患者。

4.2.5 留针

应注意安全，针体应稍露出头皮，不宜碰触留置在头皮下的毫针，以免折针、弯针。如局部不适，可稍稍退出 1 cm 左右。对有严重心脑血管疾病而需要长期留针者，应加强监护，以免发生意外。留针分为以下两种：

——**静留针**：在留针期间不再施行任何针刺手法，让针体安静而自然地留置在头皮内。一般情况下，头针留针时间宜在 15 min～30 min。如症状严重、病情复杂，病程较长者，可留针 2 h 以上。

——**动留针**：在留针期间内，间歇重复施行相应手法，以加强刺激，在较短时间内获得即时疗效。一般情况下，在 15 min～30 min 内，宜间歇行针 2 次～3 次，每次 2 min 左右。

4.2.6 出针

先缓慢出针至皮下，然后迅速拔出，拨针后应用消毒干棉球按压针孔，以防出血。

4.3 施术异常情况的处理

头针施术过程或施术后，出现晕针、滞针、弯针、断针或血肿等异常时，处理和预防按照附录 B 执行。

5 注意事项

5.1 留针应注意安全，针体应稍露出头皮，不宜碰触留置在头皮下的毫针，以免折针、弯针。如局部不适，可稍稍退出 1 cm 左右。对有严重心脑血管疾病而需要长期留针者，应加强监护，以免发生意外。

5.2 对精神紧张、过饱、过饥者应慎用，不宜采取强刺激手法。

5.3 头发较密部位常易遗忘所刺入的毫针，起针时需反复检查并核对针数。

5.4 头针长时间留针，并不影响肢体活动，在留针期间可嘱患者配合运动，有提高临床疗效的作用。

6 禁忌

6.1 囟门和骨缝尚未骨化的婴儿。

6.2 头部颅骨缺损处或开放性脑损伤部位，头部严重感染、溃疡、瘢痕者。

6.3 患有严重心脏病，重度糖尿病，重度贫血、急性炎症、心力衰竭者和凝血功能障碍疾病。

6.4 中风患者，急性期如因脑血管意外引起有昏迷、血压过高时，暂不宜用头针治疗，应待血压和病情稳定后方可做头针治疗。

附 录 A
（资料性）
头针穴线的定位和主治

A.1 头针穴线

A.1.1 MS1 Ezhongxian 额中线

Middle Line Of Forehead,1 cun long from Shenting (DU_{24}) straight downward along the meridian

A.1.2 MS2 Epangxian Ⅰ 额旁 1 线

Line 1 Lateral to Forehead,1 cun long from Meichong(BL3)straight downward along the meridian

A.1.3 MS3 Epangxian Ⅱ 额旁 2 线

Ling 2 lateral to Forehead,1 cun long from TouLinQi(GB15)straight downward along the meridian

A.1.4 MS4 Epangxian Ⅲ 额旁 3 线

Line 3 Lateral to Forehead,1 cun long from the point 0.75 cun medial toTouwei (ST8)straight downward

A.1.5 MS5 Dingzhongxian 顶中线

Middle line of Vertex,From Baihui (DU20) to Qianding (DU21) along the midline of head

A.1.6 MS6 Dingnie Qianxiexian 顶颞前斜线

Anterior Oblique Line of Vertex-Temporal,From Qianding (DU21) oblique to Xuanli(GB6)

A.1.7 MS7 Dingnie Houxiexian 顶颞后斜线

Posterior Oblique Line of Vertex-Temporal,From Baihui (DU20) obliquely to Qubin (GB7)

A.1.8 MS8 Dingpangxian Ⅰ 顶旁 1 线

line 1 Lateral to Vertex,1.5 cun long lateral to Middle line of vertex,1.5 cun long from Tongtian (BL7) backward along the meridan

A.1.9 MS9 Dingpangxian Ⅱ 顶旁 2 线

Line 2 Lateral to Vertex,2.25 cun lateral to middle line of vertex,1.5 cun long from Zhengying (GB17) backward along the meridian

A.1.10 MS10 Nieqianxian 颞前线

Anterior Temporal Line,From Hanyan(GB4) to XuanLi (GB6)

A.1.11　MSll　Niehouxian　颞后线

Posterior Temporal Line,From Shuaigu(GB8) to Qubin (GB7)

A.1.12　MSl2　Zhengshang Zhengzhong xian　枕上正中线

Upper-Middle Line of Occiput,From Qianjian(DU18) to Naohu(DU17)

A.1.13　MS13　Zhengshang Pangxian　枕上旁线

Upper-Middle Line of Occiput,0.5 cun Lateral and parallel to Upper-Middle Line of Occiput

A.1.14　MS14　Zhengxia Pangxian　枕下旁线

Lower-Lateral Line of Occiput,2 cun long from Yuzhen(BL9) straight downward

A.2　定位与主治

A.2.1　额区

头正面头针穴线见图 A.1。

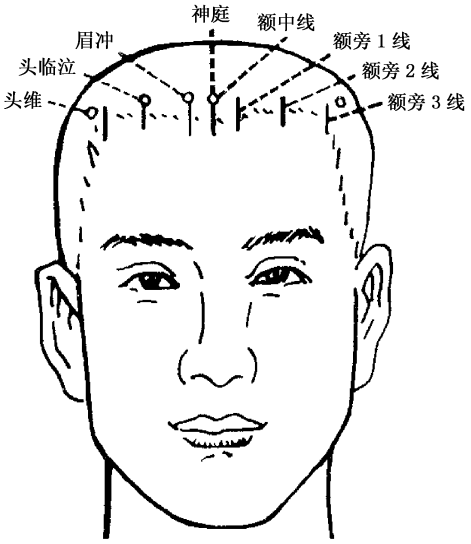

图 A.1　头正面头针穴线图示

头正面头针主要穴线如下：

——额中线

定位：在额部正中，前发际上下各 0.5 寸，即自神庭穴(DU24)向下针 1 寸，属督脉。

主治：头痛、强笑、自哭、失眠、健忘、多梦、癫狂痫、鼻病等。

——额旁 1 线

定位：在额部，额中线外侧直对目内眦角，发际上下各半寸，即自眉冲穴(BL2)沿经向下刺 1 寸，属足太阳膀胱经。

主治：冠心病、心绞痛、支气管哮喘、支气管炎、失眠等上焦病证。

——额旁 2 线

定位：在额部，额旁 1 线的外侧，直对瞳孔，发际上下各半寸，即自头临泣(GB15)向下针 1 寸，属足少阳胆经。

主治：急慢性胃炎、胃十二指肠溃疡、肝胆疾病等中焦病证。

——额旁 3 线

定位：在额部，额旁 2 线的外侧，自头维穴(ST8)的内侧 0.75 寸处，发际上下各 0.5 寸，共 1 寸，属足少阳胆经与足阳明胃经之间。

主治：功能性子宫出血、阳痿、遗精、子宫脱垂、尿频、尿急等下焦病证。

A.2.2 顶区

头顶头针穴线见图 A.2。

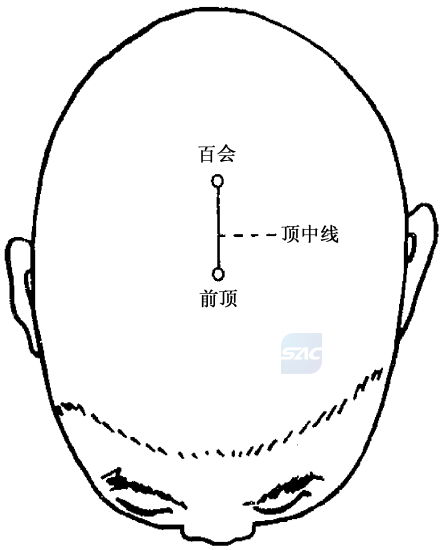

图 A.2 头顶头针穴线图示

头侧面头针穴线见图 A.3 和图 A.4。

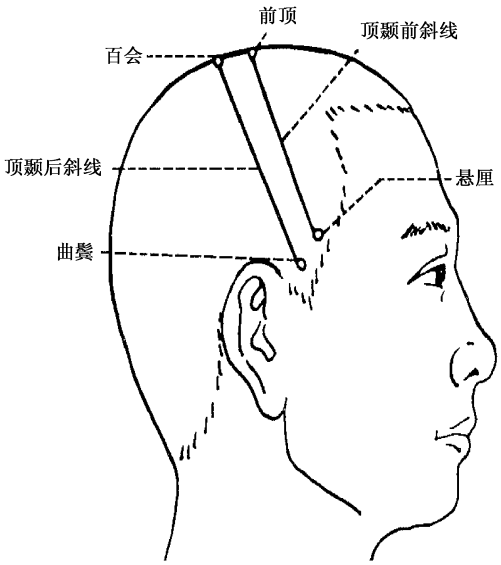

图 A.3 头侧面头针穴线图示(一)

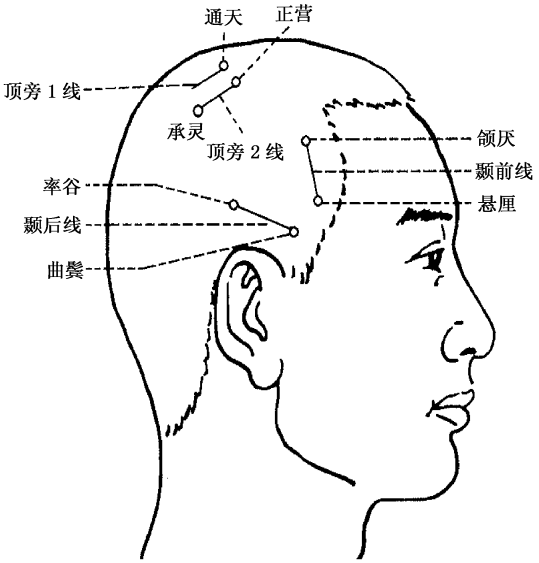

图 A.4　头侧面头针穴线图示(二)

顶区主要穴位的定位和主治如下：

——顶中线

定位：在头顶正中线上，自百会穴(DU20)向前 1.5 寸至前顶穴(DU21)，属督脉。

主治：腰腿足病证，如瘫痪、麻木、疼痛、皮层性多尿、小儿夜尿、脱肛、胃下垂、子宫脱垂、高血压、头顶痛等。

——顶颞前斜线

定位：在头部侧面，从前顶穴(DU21)至悬厘穴(GB6)的连线，此线斜穿足太阳膀胱经、足少阳胆经。

主治：对侧肢体中枢性运动功能障碍。将全线分 5 等分，上 1/5 治疗对侧下肢中枢性瘫痪；中 2/5 治疗对侧上肢中枢性瘫痪；下 2/5 治疗对侧中枢性面瘫、运动性失语、流涎、脑动脉硬化等。

——顶颞后斜线

定位：在头部侧面，从百会穴(DU20)至曲鬓穴(GB7)的连线。此线斜穿督脉、足太阳膀胱经和足少阳胆经。

主治：对侧肢体中枢性感觉障碍。将全线分成 5 等分，上 1/5 治疗对侧下肢感觉异常；中 2/5 治疗对侧上肢感觉异常；下 2/5 治疗对侧头面部感觉异常。

——顶旁 1 线

定位：在头顶部，顶中线左右各旁开 1.5 寸的两条平行线，自通天穴(BL7)起向后针 1.5 寸，属足太阳膀胱经。

主治：腰腿足病证，如瘫痪、麻木、疼痛等。

——顶旁 2 线

定位：在头顶部，顶旁 1 线的外侧，两线相距 0.75 寸，距正中线 2.25 寸，自正营穴(GB17)起沿经线向后针 1.5 寸，属足少阳胆经。

主治：肩、臂、手病证，如瘫痪、麻木、疼痛等。

A.2.3　颞区

颞区头针穴线见图 A.4、图 A.5，主要穴位的定位和主治如下：

——颞前线

定位：在头部侧面，颞部两鬓内，从额角下部向前发际处颔厌穴(GB4)到悬厘穴(GB7)，属足少阳

胆经。

主治：偏头痛、运动性失语、周围性面神经麻痹及口腔疾病等。

——颞后线

定位：在头部侧面，颞部耳上方，耳尖直上自率谷穴(GB8)到曲鬓穴(GB7)，属足少阳胆经。

主治：偏头痛、眩晕、耳聋、耳鸣等。

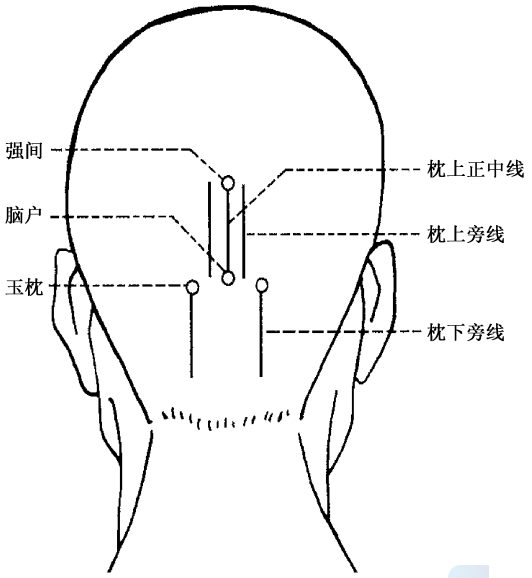

图 A.5　头后面头针穴线图示

A.2.4　枕区

枕区头针穴位见图 A.5，主要穴位的定位和主治如下：

——枕上正中线

定位：在枕部，枕外粗隆上方正中的垂直线。自强间穴(DU18)至脑户穴(DU17)，属督脉。

主治：眼病。

——枕上旁线

定位：在枕部，枕上正中线平行向外 0.5 寸。

主治：皮层性视力障碍、白内障、近视眼、目赤肿痛等眼病。

——枕下旁线

定位：在枕部，从膀胱经玉枕穴(BL9)，向下引一直线，长 2 寸，属足太阳膀胱经。

主治：小脑疾病引起的平衡障碍、后头痛、腰背两侧痛。

说明：一般标准中所涉及的长度、宽度的计量要求采用国际单位制，但由于人体高矮胖瘦的差异较大，无法采用绝对的标准值描述腧穴部分，只有通过等分析折量的方法——骨度折量法描述，才能适用于所有人群和所有个体。1987 年世界卫生组织在韩国汉城召开的国际会议上被确定采用“寸”作为针灸经穴标准计量单位。另外，寸是根据不同人体的高矮胖瘦有变化的，所以也无法用国际计量方法来计算。因此，本部分穴线定位采用这种计量单位。

附　录　B
（规范性）
头针异常情况的处理和预防

B.1　晕针

B.1.1　临床表现

在头针操作过程中，患者突然出现精神疲倦，头晕目眩，面色苍白，恶心欲吐，多汗、心慌，四肢发冷，血压下降，脉象沉细，或神志昏迷，扑倒在地，唇甲青紫，二便失禁，脉微细欲绝。

B.1.2　处理方法

应立即停止针刺，将针全部起出。使患者平卧，注意保暖，轻者仰卧片刻，给饮温开水或糖水，即可恢复。重者在上述处理基础上，可刺人中、内关、足三里、灸百会、关元、气海等穴，即可恢复，若仍不省人事，呼吸微弱者，可考虑配合其他治疗，采用急救措施。

B.1.3　预防措施

B.1.3.1　对初诊患者要详细询问是否做过针刺治疗，有无晕针史，仔细审察体质强弱，预先做好有关治疗的解释工作。

B.1.3.2　有晕针史者，应选择舒适持久的体位，宜采用卧位，选穴宜少，一般不做强刺激手法，可沿皮浅刺而不留针，若必须用强刺激手法，其频率、幅度、用力程度宜适当，要在患者能耐受的情况下，逐步使其有一个适应过程。

B.1.3.3　饥饿、劳累、过饱、醉酒时，不应采用头针治疗。

B.1.3.4　医者在针刺治疗过程中，要精神集中，随时注意观察患者的神色，询问患者的感觉，一旦有不适等晕针先兆，可及早采取处理措施，防患于未然。

B.2　滞针

B.2.1　临床表现

滞针在头针治疗中常易发生。针刺入头皮以后，医者感觉针下涩滞，捻转、提插、出针均感困难而患者则感觉痛剧。

B.2.2　处理方法

发生滞针后，应适当延长留针时间，嘱患者身心放松，并在针体周围轻柔按摩。

B.2.3　预防措施

滞针主要发生于单向快速捻转的情况下。临床上，要注意手法用力均匀和适当，避免用蛮力，避免单向捻转。

B.3　弯针和断针

B.3.1　临床表现

针体在头穴内、外发生弯曲或折断。

B.3.2 处理方法

出现弯针和断针后，不应再行提插、捻转等手法。如针柄轻微弯曲，应慢慢将针起出，若弯曲角度过大时，应顺着弯曲方向将针起出。不应强行拨针，以免将针体折断，留在体内。如果已经发生断针，若尚有残端显露于体表外，可用手或镊子将针起出。若断端与皮肤相平或稍凹陷于体内者，可用左手拇、食二指垂直向下挤压针孔两旁，使断针暴露体外，右手持镊子将针取出，若断针完全深入皮下，应在 X 线下定位，手术取出。

B.3.3 预防措施

应认真检查针具质量，凡有折痕，锈蚀的毫针绝不能使用。另外，在留针和行针过程中，应嘱咐患者避免针柄被外力碰触，以防发生弯针和断针。

B.4 血肿

B.4.1 临床表现

由于头皮部血管丰富，常易发生进针、留针时局部疼痛和出针后皮下出血，而引起的肿痛，称为血肿。

B.4.2 处理方法

若微量的皮下出血而局部小块青紫时，一般不必处理，可以自行消退。若局部肿胀疼痛较剧，青紫面积大，应先做冷敷止血后，再做热敷或在局部轻轻揉按，以促使局部瘀血消散吸收。

B.4.3 预防措施

仔细检查针具，熟悉人体头部的解剖学位置关系，避开血管针刺，出针时立即用消毒干棉球揉按压迫针孔。对于容易出血的患者，出针宜轻快，并马上按压针孔，少留针或不留针。